

症例1 | 左血気胸・多発肋骨骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「BP 78/52、HR 122、SpO2 85%RA→酸素後90%、RR 40」を提示する。一次トリアージ所見：左胸部痛、呼吸困難、SpO2低下、左呼吸音減弱、顔面蒼白

傷病者役

左胸部を押さえ、浅く速い呼吸。会話は短い単語のみ。横になることを嫌がり座位を希望。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル「BP 78/52、HR 122、SpO2 85%RA→酸素後90%、RR 40」と診察所見「左胸部圧痛著明、左呼吸音減弱、顔面蒼白、呼吸苦著明。」を提示。検査：CT: 左血気胸、多発肋骨骨折。胸腔ドレーン挿入時の初期排液1000mL、その後150mL/hで持続出血。

治療判断を確認：胸腔ドレーン、輸液・輸血、呼吸器外科コンサルト。150mL/hの持続出血では直ちに手術と決め打ちせず、ICUへ入室して経過観察する。ICU入室後に出血量が増大したら、ICUから手術室へ搬送して開胸止血し、術後はICU管理とする。

チェック：□ 高流量酸素と気道・呼吸の評価

☐ 胸腔ドレーンを留置し初期排液量と時間排液量を記録

☐ 早期に輸血（大量輸血プロトコル）を開始

☐ 150mL/hの持続出血を受けて呼吸器外科へコンサルト

☐ ICU入室・経過観察を本部・ICUへ依頼

☐ ICU入室後の出血量増大を提示

☐ ICUから手術室への搬送と開胸止血を調整

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、コントローラーは「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 78/52、HR 122、SpO2 85%RA→酸素後90%、RR 40を確認させる。

画像

プレイヤーが胸部CT撮影を決定した時点で、「CT画像のQRコード」を提示する。画像確認後に、左血気胸・多発肋骨骨折、胸腔ドレーン初期排液1000mL・以後150mL/hを伝える。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：救急車①で搬入する赤症例。直後（10:08）に症例2が乗用車で来院するため、初療ベッド配分と赤症例の優先順位判断を促す。胸腔ドレーン後は排液150mL/hで持続するため、呼吸器外科へコンサルトし、ICUへ入室して経過観察とする。

ICU入室後の急変

排液量・出血量が増大し、血圧低下・呼吸状態悪化を提示する。ICUから手術室へ搬送して開胸止血を行う判断を促す。

対応できた場合

ICUで経過観察後、急変を認識して手術室へ搬送し、開胸止血・術後ICU管理へ進む。

遅れた場合

150mL/hの持続出血を見逃し、出血量が増大。BP 60台・HR 140以上、換気困難へ悪化する。

傷病者役

左胸部を押さえ、浅く速い呼吸。会話は短い単語のみ。初療後は呼吸が少し楽になるが、ICU入室後の急変はコントローラー提示のみとする。

症例2 | 不安定型骨盤骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。一次トリアージ所見：歩行: 歩行不可扱い（または歩行可能に見えても立位保持困難）。呼吸: RR 30。循環: 脈拍数140、橈骨動脈触知不良、冷汗あり。意識: JCS30、簡単な指示に従えない

傷病者役

刺激で開眼するがすぐ閉眼。意味のある会話は困難。左骨盤部を触られると痛みで反応。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル「BP 74/42、HR 140、SpO2 94%RA、RR 30」と診察所見「顔面蒼白、冷汗著明、左骨盤部圧痛・変形、骨盤動揺性あり。」を提示。検査：骨盤X線/CT: 不安定型骨盤骨折。TAE後: Hb 7.2へ低下、乳酸 5.0mmol/L。

治療判断を確認：サムスリング固定、輸液・輸血、TAE（AG）で止血。TAE後も血圧が不安定で輸血継続を要し、骨盤内パッキング・創外固定を検討のうえICU入室。

チェック：□ 歩行可能に見えても赤ヘトリアージアップし救外へ誘導

□ 骨盤ベルト（サムスリング）を早期に装着

□ 骨盤動揺性の反復診察を避ける

□ 輸液・輸血（大量輸血プロトコル）を開始

□ AG室へTAEを依頼し搬送を調整

□ TAE後に再評価し、輸血継続とICU入室を依頼

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、コントローラーは「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 74/42、HR 140、SpO2 94%RA、RR 30を確認させる。

画像

プレイヤーが骨盤X線またはCT撮影を決定した時点で、「画像のQRコード」を提示する。不安定型骨盤骨折を確認後に、TAE後のHb 7.2、乳酸 5.0を数値で提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車1で来院。一見歩けそうに見えるが骨盤骨折によるショックで、トリアージアップして救外ゾーンへ直接誘導する判断を促す。TAE終了後にERで血圧再低下と乳酸上昇を付与し、輸血継続とICU入室依頼を判断させる（演技不要、コントローラーが数値で提示）。

分岐：対応できた場合: 骨盤固定と輸血でBP 90台へ改善し、TAE後もICUで循環管理・輸血継続につなげられる。

遅れた場合: 後腹膜出血が進行しBP 60台・HR 150へ。動揺性の反復診察や晶質液のみの補正で凝固障害が加わり循環虚脱に至る。

傷病者役

刺激で開眼するがすぐ閉眼。意味のある会話は困難。左骨盤部を触られると痛みで反応。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：不安定型骨盤骨折では、骨盤の外固定と早期止血が重要。動揺性の反復診察は再出血を招くため避ける。TAE後も循環が不安定なら再出血・他部位出血を検索し、ICUで輸血を継続する。

症例3 | 急性硬膜外血腫

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「来院時 HR 80、BP 160/80、SpO2 100%。初期JCS 10、GCS 11（E3V3M5）」を提示する。

一次トリアージ所見

頭部打撲、一時意識消失、瞳孔不同、徐脈・高血圧傾向

傷病者役

来院時はなんとか従命可能。CT後に意識レベル著明低下。痛み刺激に払いのけるのみ、発語なし。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：来院時 HR 80、BP 160/80、SpO2 100%。初期JCS 10、GCS 11（E3V3M5）

診察所見

歩行不可。

治療判断

気管挿管、緊急開頭血腫除去術。脳外傷術後のためICUまたはEUで管理。

進行指示

初療時は従命可能、CT結果提示後にGCS低下・瞳孔不同を付与。脳神経外科・手術室・ICUへ緊急連絡し、気管挿管、緊急開頭血腫除去術、術後ICU管理へ進める。

確認項目

- ☐ 頭部CTの優先順位を判断し早期に撮影
- ☐ CT後の意識低下・瞳孔不同・徐脈＋高血圧を認識
- ☐ GCS≤8でRSIIによる気管挿管を実施
- ☐ 脳神経外科・手術室へ緊急開頭を要請
- ☐ 術後のICU/EU入室を調整

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、来院時 HR 80、BP 160/80、SpO2 100%。初期JCS 10、GCS 11（E3V3M5）を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、頭部CT: 急性硬膜外血腫。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（談当時）

コントローラー

追加イベント：症例19（黄・右大腿骨骨折）と同時到着。救外・軽症ゾーンの振り分けを確認する。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 挿管で気道と換気が保たれ、早期の開頭血腫除去で神経学的予後が保たれる。

遅れた場合: 舌根沈下・低酸素による二次性脳損傷が加わり、脳ヘルニアが進行して不可逆的な神経障害に至る。

傷病者役

来院時はなんとか従命可能。CT後に意識レベル著明低下。痛み刺激に払いのけるのみ、発語なし。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：急性硬膜外血腫はlucid intervalの後に急速悪化するため、一時的な意識改善で油断しない。

徐脈＋高血圧（Cushing現象）と片側瞳孔散大は切迫脳ヘルニアのサイン。

GCS≤8では気道確保を行い、開頭血腫除去は時間依存性が高い。

脳神経外科・手術室・ICUを同時に立ち上げる連携。

症例4 | 左外踝骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不可。呼吸: 見たまま安定。循環: 脈拍は見たまま、明らかなショックなし。意識: 指示に従える

傷病者役

支えれば立位可。痛み強い。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

左外踝圧痛、腫脹。

治療判断

シーネ固定

進行指示

左足関節腫脹と歩行不可を提示。シーネ固定と画像検査の導線確認を促す。

確認項目

☐ 歩行不能の黄として軽症ゾーンへ誘導

☐ 末梢循環・知覚を確認

☐ X線を依頼し画像導線を確認

☐ シーネ固定と鎮痛を実施

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で左外踝骨折。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車1の同乗者として来院。緑症例と同時に軽症ゾーンへ流入し、受付・画像導線を混雑させる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: シーネ固定と鎮痛で疼痛が軽減し、帰宅可能。

遅れた場合: 固定されないまま移動を繰り返し疼痛と腫脹が増強、軽症ゾーンの車椅子・ストレッチャー不足が顕在化する。

傷病者役

支えれば立位可。痛み強い。

固定情報・備考	ムラージュ：左足関節腫脹 学習ポイント：歩行不能は軽症に見えても黄として扱う。 足関節外傷では外踝骨折を念頭に置き、末梢循環・知覚を確認する。 シーネ固定と鎮痛で帰宅可能な症例でも、画像検査の導線確保が必要。
---------	--

症例5 | 回転性めまい・歩行不能→シートベルト損傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: 見たまま安定。循環: 脈拍は見たまま、機脅動脈触知良好。意識: 指示に従える（閉眼・嘔気あり）

傷病者役

閉眼でめまい増強。点滴後にめまいは改善するが、コントローラーの合図で腹痛を訴える。以後は手術が決まったと伝えられるまで、かなり強い腹痛を訴え続け、腹部を押さえてぐったりする。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BP 118/70、HR 88、SpO2 98%RA、RR 16

診察所見

眼振あり、四肢麻痺なし。下腹部に斜めの帯状皮下出血・擦過（シートベルト痕）。腹痛出現後は臍周囲～下腹部に強い圧痛と筋性防御、腸雑音低下。

治療判断

点滴・鎮痛のうえ経過観察としたが、腹痛出現後にFAST陽性・造影CTで腸管損傷＋腸間膜損傷による腹腔内出血を確認し、シートベルト損傷として外科で緊急開腹（止血・損傷腸管の処理）。腹部術後のためICU管理。

進行指示

シートベルト着用中の衝突で、車内での頭部打撲後にめまいが出現。神経局なし、歩行不能、嘔気を提示する。点滴開始後、合図で腹痛を訴えさせ、下腹部の帯状皮下出血（シートベルト痕）、BP 86/58・HR 122、FAST陽性、造影CTで腸管損傷＋腸間膜損傷による腹腔内出血を提示。軽症ゾーンから救外への移送、外科コンサルト、緊急開腹と術後ICU入室の調整を判断させる。学生には手術決定が伝えられるまで、かなり強い腹痛を訴え続けさせる。

確認項目

- ☐ 下腹部のシートベルト痕に気づく
- ☐ 軽症ゾーンでバイタルと腹部所見を反復評価
- ☐ 腹痛出現時にFASTを実施し陰性でも再検を検討
- ☐ 赤へアップトリアージし救外へ移送
- ☐ 外科コンサルトと造影CTを手配
- ☐ 緊急開腹の手術室と術後ICUを同時に調整

検査・モニター提示

モニター

ブレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 118/70、HR 88、SpO2 98%RA、RR 16を確認させる。

検査・画像

ブレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、頭部MRI異常なし。腹痛出現後: FAST陽性（モリソン窩・骨盤内に液体貯留）。造影CTで腸間膜からの造影剤漏出と腸管壁の血流不良、腹腔内液体貯留、腹壁のシートベルト痕に一致する皮下血腫。Hb 9.2、乳酸 4.2mmol/L₀を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車1の同乗者として来院（シートベルト着用）。軽症ゾーンで点滴中（来院約30分後）に腹痛を訴える。下腹部のシートベルト痕に気づけるかを含め、避発性に腹部所見が出現するシートベルト損傷（腸管・腸間膜損傷）として、軽症ゾーンから救外への移送、緊急手術と術後ICUの手配につなげる判断を促す。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 腹痛出現直後に再評価し、輸液・輸血を行いながら緊急開腹へ進め、循環を保ったまま術後ICUへ入室できる。

遅れた場合: 「めまいの患者」という先入観で経過観察され、BP 70台・HR 130へ進行して筋性防御が明らかになり、腹膜炎・敗血症へ進展する。

傷病者役

閉眼でめまい増強。点滴後にめまいは改善するが、コントローラーの合図で腹痛を訴える。以後は手術が決まったと伝えられるまで、かなり強い腹痛を訴え続け、腹部を押さえてぐったりする。

固定情報・備考

ムラージュ：下腹部に斜めの帯状皮下出血・擦過傷（シートベルト痕）

学習ポイント：腹壁の帯状皮下出血（シートベルト徴候）を見たら腸管・腸間膜損傷とChance骨折を疑う。

腸管・腸間膜損傷は初期のFAST・診察で所見が乏しく、避発性にショック化する。

軽症ゾーンに振り分けた患者でも反復評価とアップトリアージが不可欠。

災害時は緊急手術枠と術後ICUベッドを同時に確保する。

症例6 | 前腕擦過傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

普通に会話、処置を待てる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

前腕浅い擦過傷。

治療判断

洗浄/被覆

進行指示

前腕擦過傷のみ、バイタル安定。洗浄・被覆後帰宅可能とする。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、画像不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：緑患者の受付・帰宅導線確認に使用。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 洗浄・被覆で処置完了となり、帰宅導線に乘せられる。
遅れた場合: 軽症者が軽症ゾーンに滞留し、受付・処置待ちが混雑して重症度の高い患者の対応が遅れる。

傷病者役

普通に会話、処置を待てる。

固定情報・備考

ムラージュ：前腕擦過傷

学習ポイント：浅い擦過傷は洗浄・被覆で対応し、画像検査は不要。

緑症例を滞りなく帰宅させる導線確保が、軽症ゾーン全体の回転を決める。

症例7 | 足背切創

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

傷の処置希望。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

浅い切創、腱損傷なし。

治療判断

洗浄/縫合検討

進行指示

止血済み、浅切創、異物なしを提示。洗浄・縫合要否判断を促す。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、異物なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：創傷処置待ちを軽症ゾーンに発生させる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 止血確認・洗浄後に縫合要否を判断し帰宅となる。

遅れた場合: 異物確認や洗浄が不十分のまま経過し、創部感染のリスクと処置待ちの滞留が生じる。

傷病者役

傷の処置希望。

固定情報・備考

ムラージュ：足背切創

学習ポイント：切創では止血の確認に加え、異物と腱・神経損傷の有無を確認する。

浅い切創は洗浄後に縫合要否を判断し、帰宅可能。

症例8 | 軽症頸部痛

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

首が少し痛い程度。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

神経脱落なし、正中圧痛なし。

治療判断

鎮痛/帰宅

進行指示

神経症状なし、正中圧痛なしを提示。過剰検査を避けた帰宅判断を促す。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、画像不要または異常なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症者の説明・帰宅導線を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 神経所見と正中圧痛がないことを確認し、鎮痛と説明で帰宅となる。

遅れた場合: 全例にX線やCTを出して画像室が混雑し、重症例の検査が後回しになる。

傷病者役

首が少し痛い程度。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：頸部痛では神経脱落症状と正中圧痛の有無で画像の必要性を判断する。

災害時は限られた画像資源を守るため、過剰検査を避けた帰宅判断が重要。

症例9 | 足関節捻挫

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

少し足を引きずる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

外踝周囲圧痛軽度。

治療判断

固定/帰宅

進行指示

歩行可能、腫脹軽度、X線骨折なしを提示。固定・帰宅判断へ。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で骨折なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：緑患者の同時多数来院として軽症ゾーン混雑を演出。

分岐・悪化条件

対応できた場合: X線で骨折なしを確認し、固定と鎮痛で帰宅となる。

遅れた場合: 歩行可能な緑症例の画像依頼が重なり、軽症ゾーンと画像室が混雑して黄・赤症例の検査が遅れる。

傷病者役

少し足を引きずる。

固定情報・備考	ムラージュ：足関節腫脹軽度 学習ポイント：歩行可能で腫脹軽度なら緑として扱い、固定・鎮痛で帰宅とする。 災害時の画像検査は優先順位をつけ、軽症例では臨床判断で代替することも検討する。
---------	---

症例10 | 手指切創

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in. 歩行: 可能. 呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

処置を待てる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

浅い切創、可動域良好。

治療判断

洗浄/テープ固定

進行指示

止血済み、腱損傷なしを提示。洗浄・テープ固定で帰宅可能とする。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、腱損傷なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症創傷が複数同時に来る状況を作る。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 腱損傷なしを確認し、洗浄・テープ固定で帰宅となる。

遅れた場合: 軽症創傷が同時に滞留し、処置待ちの列が伸びて軽症ゾーンの回転が悪化する。

傷病者役

処置を待てる。

固定情報・備考	ムラージュ：手指切創
	学習ポイント：手指切創では可動域と腱・神経損傷の有無を必ず確認する。
	浅い創は洗浄・テープ固定で十分で、軽症創傷の並列処理がゾーン運営の鍵となる。

症例11 | 頭痛・不眠

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in. 歩行: 可能. 呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

疲労感と不眠を訴える。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

神経脱落症状なし。

治療判断

内服/帰宅

進行指示

神経症状なし、バイタル安定を提示。傾聴と帰宅判断を促す。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、検査不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーンで不安訴えへの対応を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 神経症状がないことを確認し、傾聴と内服で帰宅となる。

遅れた場合: 説明に長時間を要して軽症ゾーンの人員が拘束され、他の黄症例の再評価が遅れる。

傷病者役

疲労感と不眠を訴える。

固定情報・備考	ムラージュ：記載なし 学習ポイント：災害ストレスによる頭痛・不眠は神経症状のないことを確認し、過剰検査を避ける。 傾聴と説明、必要なら内服で帰宅とし、心理面のフォロー先を伝える。
---------	--

症例12 | 軽微外傷＋発熱（幼児）

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

徒歩来院（母同伴）。歩行: 可能（幼児設定は保護者同伴で活気あり）。呼吸: RR 28、努力呼吸なし。循環: HR 150だが発熱性頻脈として扱い、末梢冷感なし。意識: 活気あり、指示/呼びかけに反応良好

傷病者役

乳幼児人形を使用。母役が付き添い「もともと発熱で小児科受診予定だった」と説明。外傷は軽微。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BT 38.6、HR 150（発熱性頻脈）、SpO2 98%RA、RR 28、活気あり

診察所見

前額部・膝の擦過傷のみ、頭部血腫なし、咽頭発赤あり。神経学的異常なし。

治療判断

創処置＋解熱剤処方。発熱診療は小児科へ引き継ぎ／帰宅。

進行指示

発熱性頻脈をショックと取り違えないよう指導。緑トリアージの妥当性を確認。

確認項目

- ☐ 発熱性頻脈をショックと取り違えず緑と判定
- ☐ 外傷は創処置のみで対応し画像の適応を判断
- ☐ 嘔吐・意識変容などの危険徴候を確認
- ☐ 発熱診療の行き先（小児科引き継ぎ／帰宅）を明確化
- ☐ 家族へ帰宅後のred flagを説明

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BT 38.6、HR 150（発熱性頻脈）、SpO2 98%RA、RR 28、活気ありを確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、外傷検索の画像は基本不要。発熱に対し必要に応じ迅速検査。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：母同伴で徒歩来院。発熱・頻脈があるが活気良好。小児科への引き継ぎ判断。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 創処置と解熱対応を行い、発熱は小児科へ引き継いで帰宅できる。

遅れた場合: 発熱性頻脈をショックと誤認して赤へ過大トリアージし資源を消耗する、あるいは「軽微外傷」に引きずられ発熱評価を怠り、活気不良・脱水などの重症感染の兆候を見逃す。

傷病者役

乳幼児人形を使用。母役が付き添い「もともと発熱で小児科受診予定だった」と説明。外傷は軽微。

固定情報・備考

ムラージュ：前額部・膝の擦過傷

学習ポイント：幼児の発熱性頻脈（BT 38.6でHR 150）は生理的範囲であり、活気と末梢循環でショックと鑑別する。

小児頭部外傷はPECARNルールで不要なCTを避ける。

緑症例でも行き先（disposition）と原疾患のフォローを明確にする。

症例13 | 重症頭部外傷（急性硬膜下血腫）

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「BP 90/60（来院時。頭部裂創・皮下血腫、呼びかけにうめくのみ、末梢冷感を伴う外傷性ショック。」を提示する。

一次トリアージ所見

歩行不能、呼びかけにうめき声のみ、頭部裂創からの出血を伴うショックバイタル

傷病者役

中学生役は学生が演じる（学生演技）。身元不明。来院時は呼びかけにうめくのみで反応が乏しい。ICU入室後、コントローラーの指示のタイミングで片側瞳孔が散大する（アニソコリア）。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BP 90/60（来院時。頭部裂創・皮下血腫、呼びかけにうめくのみ、末梢冷感を伴う外傷性ショック

診察所見

来院時は瞳孔左右差・明らかな四肢麻痺なし。

治療判断

気管挿管（RSI）、頭皮止血・輸血。初期CTでは緊急手術の適応なく、挿管管理のままICU入室し経過観察。ICU入室後の瞳孔不同・血腫増大を受けて緊急開頭血腫除去術。術後もICU管理。

進行指示

初期CTは少量の急性硬膜下血腫で正中偏位・脳浮腫なし、FAST陰性と提示し、脳神経外科は緊急手術不要と判断させる。頭皮止血・輸血後はバイタル安定を伝え、挿管管理のままICU入室へ。ICU入室後の良いタイミングで瞳孔不同の出現を伝え、CT再検で血腫増大を提示して緊急手術へ移行させる。ICUと手術室の連絡・緊急手術の受け入れ調整を評価する。

確認項目

- ☐ GCS 8で頸椎保護下のRSIによる気管挿管を実施
- ☐ 頭皮裂創を圧迫・縫合/ステープルで止血
- ☐ 輸血を開始し、他部位の出血源をFASTなどで検索
- ☐ 初期CTの所見を脳神経外科と共有し方針を確認
- ☐ 挿管管理のままICU入室を調整
- ☐ ICUで瞳孔・GCSを反復評価し、瞳孔不同出現時にCTを再検
- ☐ ICUから手術室・脳神経外科へ緊急開頭を要請し受け入れを調整
- ☐ 身元不明患者としての登録・緊急輸血・家族探索を並行

検査・モニター提示

モニター

ブレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 90/60（来院時。頭部裂創・皮下血腫、呼びかけにうめくのみ、末梢冷感を伴う外傷性ショックを確認させる。

検査・画像

ブレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、頭部CTで少量の急性硬膜下血腫。正中偏位・脳浮腫はなし。FASTは陰性。ICU入室後に瞳孔不同が出現し、再検CTで血腫増大を確認。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：気道確保（RSI）と頭皮止血・輸血の同時進行。止血・輸血後にバイタルは安定し、初期CTでは緊急手術の適応なくICU入室。ICU入室後の良いタイミングで瞳孔不同が出現し、CT再検で血腫増大、緊急手術となる二段階の展開。ICUと手術室の連絡調整が必要。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 挿管と頭皮止血・輸血でBP 120/70と循環が安定し、ICUでの反復評価により瞳孔不同を直ちに捕らえてCT再検→緊急開頭血腫除去術へ短時間で移行できる。

遅れた場合: 挿管が遅れば舌根沈下・低換気で頭蓋内圧が上昇しCPAに至る。止血・輸血が遅れば出血性ショックが増悪し二次性脳損傷を助長する。ICUでの瞳孔変化を見逃す・CT再検や手術室連絡が遅れると、テント切痕ヘルニアが進行し不可逆的脳損傷となる。

傷病者役

中学生役は学生が演じる（学生演技）。身元不明。来院時は呼びかけにうめくのみで反応が乏しい。ICU入室後、コントローラーの指示のタイミングで片側瞳孔が散大する（アニソコリア）。

固定情報・備考

ムラージュ：頭部の大きな裂創からの活動性出血、皮下血腫、顔面血液付着

学習ポイント：小児は頭皮出血だけでも出血性ショックに至るため、同時に他部位の出血源も検索する。

低酸素・低血圧を避けることが二次性脳損傷予防の鍵で、GCS≤8は気道確保の適応。

初期CTが軽微でも急性硬膜下血腫は増大しうるため、ICUで瞳孔・GCSを反復評価しCT再検の閾値を低く保つ。

ICU・手術室・脳神経外科の連携と、身元不明患者への対応（推定体重での薬剤投与・緊急輸血）。

症例14 | 左腎損傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価	
0-3分	
コントローラー	乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。
一次トリアージ所見	初期は歩行可能なら緑になり得る。呼吸: 見たまま。循環: 二次直前に脈拍数132、橈骨動脈触知不良、冷汗を付与。意識: 直前に意識消失を付与
傷病者役	一次までは軽い左背部痛。二次直前に座位で意識消失。臥位で意識回復後、左背部痛を強く訴える。

固定情報・備考	ムラージュ：不要
	学習ポイント：・受傷直後は代償により歩行可能でも、進行性出血で遅れてショック化する（トリアージアップの典型例）。 ・座位・起立での失神は循環血流量減少のサインであり、二次トリアージでの再評価が要。 ・腎損傷ではFAST陰性でも造影CTで造影剤血管外漏出を確認し、TAEで止血したうえでEU入院とする。

02 初療から治療へ	
3-12分	
コントローラー	初回バイタル：BP 76/30、HR 132、SpO2 96%RA。臥位では意識清明
診察所見	左背部の強い圧痛。顔面蒼白、冷汗。腹部は平坦・軟で腹膜刺激症状なし。
治療判断	輸液・輸血、造影剤血管外漏出に対しTAE（AG）。TAE後はEU入院。
進行指示	乗用車2。一次では軽症として振る舞わせ、二次直前に低血圧・意識消失を付与。救外移動を促す。
確認項目	☐ 一次では軽症として振る舞わせ、緑判定を許容する ☐ 二次直前に座位での意識消失、BP 76/30・HR 132・冷汗を提示する ☐ 赤へのトリアージアップと救外への移動が行われるか確認する ☐ FAST陰性、造影CTで左腎損傷＋造影剤血管外漏出を提示する ☐ 輸液・輸血の開始とAG（TAE）依頼のタイミングを確認する ☐ TAE後のEU入院調整を確認する
検査・モニター提示	
モニター	プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 76/30、HR 132、SpO2 96%RA。臥位では意識清明を確認させる。
検査・画像	プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、FAST陰性。造影CT: 左腎損傷、造影剤血管外漏出あり。を提示する。

03 急変・追加設定	
12-20分（該当時）	
コントローラー	追加イベント：乗用車2で来院。同乗者から「車内に動けない人がいる」と情報提供させる。
分岐・悪化条件	対応できた場合: 輸液・輸血でBP 100/60台・HR 100前後へ改善し、TAE後は循環安定してEU入院。 遅れた場合: BP 60台、HR 140、意識レベル低下と冷汗増強、Hb低下を提示し、出血性ショックの進行を示す。
傷病者役	一次までは軽い左背部痛。二次直前に座位で意識消失。臥位で意識回復後、左背部痛を強く訴える。

症例15 | 軽症胸部打撲

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸: 見たまま安定、SpO2良好。脈拍・意識: 見たまま安定、指示に従える

傷病者役

深呼吸で少し痛がる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：SpO2 98%RA、他安定

診察所見

軽い圧痛、呼吸音左右差なし。

治療判断

鎮痛/帰宅

進行指示

呼吸苦なし、SpO2良好、呼吸音左右差なしを提示。胸部外傷の過小評価に注意させる。

確認項目

☐ 呼吸苦なし、SpO2 98%RA、呼吸音左右差なしを提示する

☐ 深呼吸時の胸痛のみで緑判定が妥当であることを確認する

☐ X線で骨折なしを提示し、鎮痛・帰宅の判断を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、SpO2 98%RA、他安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で骨折なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例14と同じ事故グループの軽症者として来院し、車内残存者の情報を補助させる。

分岐・悪化条件

特になし（経過中に呼吸苦やSpO2低下は生じない設定）。

傷病者役

深呼吸で少し痛がる。

固定情報・備考

ムラージュ：胸部打撲痕軽度

学習ポイント：・胸部打撲は軽症に見えても呼吸音の左右差とSpO2の確認が必須。

・所見が乏しければ過剰検査を避け、増悪時再診の説明のうえ帰宅可能。

症例16 | 軽いめまい

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

座ると楽になる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

麻痺なし、構音障害なし。

治療判断

休息/水分

進行指示

神経症状なし、座位で改善を提示。水分・休息で帰宅可能とする。

確認項目

- ☐ 麻痺・構音障害なし、座位で改善することを提示する
- ☐ 必要時の血糖測定が行われるか確認する
- ☐ 水分・休息後の帰宅判断を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、必要時血糖正常。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例5（回転性めまい）との重症度比較に使う。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

座ると楽になる。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：・災害時のめまいは疲労・脱水が多いが、麻痺や構音障害など中枢性所見の確認は必須。

・症例5のように遅発性に重症化するめまいとの対比で、再評価の必要性を意識させる。

症例17 | 一過性動悸

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

車から降りたら、まだ車内に動けない人がいると伝える。一次トリアージまでは動悸を訴え、その後は症状軽快として普通にふるまう。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値

診察所見

余裕で歩行可能。症状は消失し、早く帰りたいと訴える。

治療判断

不要

進行指示

乗用車2。一次では動悸を訴え、二次では軽快。車内残存者情報を本人から申告させる。

確認項目

☐ 一次では動悸を訴え、二次では症状軽快とする

☐ 「まだ車内に動けない人がいる」と本人から申告させる

☐ トリアージポストから搬送班要請が出るか確認する

☐ 検査異常なしを提示し、帰宅判断を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、異常なしを提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車2の同乗者として来院。「まだ車内に動けない人がいる」と伝え、トリアージポストから搬送班要請を促す。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

車から降りたら、まだ車内に動けない人がいると伝える。一次トリアージまでは動悸を訴え、その後は症状軽快として普通にふるまう。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：・walk-in患者がもたらす現場情報（車内残存者）は搬送調整の重要な手がかりになる。

・循環不全所見のない一過性の動悸は、説明と経過観察で帰宅可能。

コントローラ配布資料（症例別）をもとに生成 | 症例17 | 一過性動悸

症例18 | 左膝打撲

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 可能（びっこを引くが自力歩行可）。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

びっこを引きながら歩行し、膝の曲げ伸ばしで疼痛を訴える。マイクロバス内で前座席に膝をぶつけたと説明する。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値

診察所見

左膝関節前面に圧痛、軽度腫脹。可動域制限は軽度。靱帯損傷を示唆する所見なし。

治療判断

不要

進行指示

乗用車2。びっこを引くが歩行可能。画像異常なしを提示し帰宅へ。

確認項目

- ☐ びっこを引くが自力歩行可能であることを提示する
- ☐ 靱帯不安定性を示す所見はないと提示する
- ☐ 画像異常なしを提示し、緑判定と帰宅の判断を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、画像異常なしを提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車2の軽症者として、同乗の症例14の急変と対比する。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

びっこを引きながら歩行し、膝の曲げ伸ばしで疼痛を訴える。マイクロバス内で前座席に膝をぶつけたと説明する。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：・荷重歩行が可能で靱帯不安定性がなければ、検査・処置は最小限でよい。

・同乗の症例14（急変例）との重症度の差を意識させる。

症例19 | 右大腿骨骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価		02 初療から治療へ		03 急変・追加設定	
0-3分		3-12分		12-20分（該当時）	
コントローラー		コントローラー		コントローラー	
救急車で到着。救急隊情報として「実測値で安定。」を提示する。		初回バイタル：実測値で安定		追加イベント：救急車④で搬入し、救外・軽症ゾーンの振り分けを確認。	
一次トリアージ所見		診察所見		分岐・悪化条件	
歩行不能、右大腿強い疼痛		右大腿圧痛、変形疑い。		対応できた場合: 鎮痛・下肢固定で疼痛が軽減し、バイタル安定のまま手術待機となる。	
傷病者役		治療判断		遅れた場合: 疼痛増強と大腿の腫脹拡大、HR 110台・BP低下傾向を提示し、骨折部出血による循環動態の変化を示す。	
右大腿を強く痛がる。麻痺なし。		鎮痛・下肢固定の上、骨接合術（OPE）。術後はEUもしくは一般病床入院。		傷病者役	
		進行指示		右大腿を強く痛がる。麻痺なし。	
		右大腿痛と歩行不能を提示。循環安定を強調する。トリアージ黄色だが、軽症ゾーンで評価する判断・救外ゾーンで評価する判断のどちらも許容し、赤症例との優先順位差を確認させる。			
		確認項目			
		☐ 右大腿痛と歩行不能を提示し、循環は安定していることを強調する			
		☐ 救外ゾーン・軽症ゾーンのどちらの判断も許容する			
		☐ 赤症例との優先順位の付け方を確認する			
		☐ X線で右大腿骨骨折を提示し、鎮痛・下肢固定が行われるか確認する			
		☐ 骨接合術の手術室調整とEU／一般病床への入院依頼を確認する			
		検査・モニター提示			
		モニター			
		プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。			
		検査・画像			
		プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で右大腿骨骨折。を提示する。			
固定情報・備考		ムラージュ：記載なし			
		学習ポイント：・大腿骨骨折は多量出血をきたし得るため、循環の反復評価が必要。			
		・早期の鎮痛と下肢固定が出血・疼痛コントロールに有用。			
		・黄症例のゾーン配置は運用次第で、赤症例との優先順位付けが要点。			

症例20 | 喘息発作

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 支え歩き。呼吸: RR 30、喘鳴あり（コントローラーが呼吸数30/分を提示）。循環: 脈拍数105、血圧は見たまま安定。意識: 指示に従える

傷病者役

短文で会話可能。咳込みあり、吸入後に改善。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：SpO2 94%、RR 30、HR 105、BP安定

診察所見

喘鳴、軽度努力呼吸。会話は短文で可能。

治療判断

吸入/帰宅

進行指示

喘鳴、RR 30、SpO2 94%を提示。吸入後改善する想定を伝える。

確認項目

☐ 喘鳴、RR 30、SpO2 94%、HR 105を提示する

☐ 黄として軽症ゾーンで呼吸を優先評価する流れを確認する

☐ 吸入後にSpO2 97%、RR 20へ改善すると提示する

☐ 帰宅判断と増悪時の再診説明を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、SpO2 94%、RR 30、HR 105、BP安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、心電図変化なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーン混雑時に呼吸器症状を混ぜ、黄判断を促す。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 吸入後 SpO2 97%RA、RR 20、喘鳴消失で帰宅可能。

遅れた場合: SpO2 90%、RR 36、会話が単語のみとなり、酸素投与と救外ゾーンへの移動が必要になる。

傷病者役

短文で会話可能。咳込みあり、吸入後に改善。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：・会話の長さ（単語／短文／文章）は呼吸困難の重症度評価に有用。

・軽症ゾーンでも呼吸器症状は優先評価し、吸入への反応を再評価する。

・改善不良なら帰宅させず酸素投与・ゾーン変更を検討する。

症例21 | 腰椎圧迫骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: 見たまま安定。循環: 脈拍は見たまま、ショック所見なし。意識: 指示に従える

傷病者役

動かすと激痛、安静なら軽快。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

腰部正中叩打痛。

治療判断

鎮痛・安静、体幹装具。EUもしくは一般病床入院。

進行指示

体動困難、腰部叩打痛、神経症状なしを提示。画像検査・入院判断を促す。

確認項目

☐ 体動困難・腰部正中叩打痛・神経症状なしを提示する

☐ 車椅子・ストレッチャーなど移動手段の確保調整を確認する

☐ CTで腰椎圧迫骨折を提示する

☐ 鎮痛・安静・体幹装具とEU／一般病床への入院調整を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、CTで腰椎圧迫骨折。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車3で来院。歩行不能患者が増え、車椅子・ストレッチャー不足を演出する。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 鎮痛で安静時痛が軽減し、入院調整へ進む。

遅れた場合: 疼痛で体動困難が続き、下肢のしびれや尿閉を提示して神経学的再評価を促す。

傷病者役

動かすと激痛、安静なら軽快。

固定情報・備考	ムラージュ：記載なし
	学習ポイント：・高齢者の転倒後腰痛では圧迫骨折を想起し、麻痺・膀胱直腸障害の有無を確認する。
	・歩行不能例は入院適応となり、災害時は移動・捜索資源の確保も課題となる。

症例22 | 左多発肋骨骨折・小気胸

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価 0-3分 コントローラー 徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。 一次トリアージ所見 Walk-in。歩行: 可能。呼吸: 呼吸数は見たまま、SpO2 96%RA、呼吸音やや低下。循環: 脈拍は見たまま安定。意識: 指示に従える 傷病者役 深呼吸で痛がる。呼吸苦は軽度。	02 初療から治療へ 3-12分 コントローラー 初回バイタル：SpO2 96%RA、他安定 診察所見 左側胸部圧痛。 治療判断 鎮痛・呼吸状態の反復評価。小気胸のためEUで入院観察。 進行指示 SpO2は保たれるが胸痛が強い設定。画像で小気胸を提示し入院観察を促す。 確認項目 ☐ 歩行可能でもSpO2 96%RA・呼吸音やや低下・強い胸痛を提示する ☐ 二次評価で黄へアップする判断を確認する ☐ X線／CTで多発肋骨骨折と小気胸を提示する ☐ 鎮痛と呼吸状態の反復評価が行われるか確認する ☐ EUでの入院観察の判断と病床調整を確認する 検査・モニター提示 モニター プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、SpO2 96%RA、他安定を確認させる。 検査・画像 プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線/CTで多発肋骨骨折、小気胸。を提示する。	03 急変・追加設定 12-20分（該当時） コントローラー 追加イベント：緑に見える胸部外傷を混ぜ、過小評価を防ぐ訓練にする。 分岐・悪化条件 対応できた場合: 鎮痛で深呼吸が可能となり、SpO2 97%RAを維持してEUで観察。 遅れた場合: SpO2 92%、RR 28、左呼吸音のさらなる低下を提示し、気胸の拡大と胸腔ドレーン検討へつなげる。 傷病者役 深呼吸で痛がる。呼吸苦は軽度。

固定情報・備考

ムラージュ：胸部打撲痕

学習ポイント：・歩行可能でも胸部外傷は過小評価しない（二次評価でのトリアージアップ）。

・小気胸は拡大リスクがあり、鎮痛と呼吸の反復評価のうえ入院観察が必要。

・鎮痛不十分は無気肺・肺炎のリスクとなる。

症例23 | 安定型骨盤骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: 見たまま安定。循環: 脈拍は見たまま、ショック所見なし。意識: 指示に従える

傷病者役

骨盤部疼痛、過換気は徐々に改善。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

骨盤圧痛、神経障害なし。

治療判断

鎮痛・安静。EUもしくは一般病床入院で経過観察。

進行指示

過換気は徐々に改善。骨盤痛・歩行不能だがショックなしを提示。

確認項目

- ☐ 骨盤圧痛・歩行不能だがショック所見はないことを提示する
- ☐ 過換気は徐々に改善させる
- ☐ CTで安定型骨盤骨折、造影剤漏出なしを提示する
- ☐ 症例2（不安定型骨盤骨折）との重症度の違いを確認させる
- ☐ 鎮痛・安静とEU／一般病床への入院調整を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、CTで安定型骨盤骨折、漏出なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車3で来院。赤の骨盤骨折（症例2）との重症度比較を行わせる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 循環は安定を維持し、鎮痛・安静のうえ入院調整へ進む。

遅れた場合: HR 110台、BP 90台への低下を提示し、骨盤固定と造影CTによる再評価を促す。

傷病者役

骨盤部疼痛、過換気は徐々に改善。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：・骨盤骨折は安定型と不安定型で循環動態と治療方針が大きく異なる。

・ショック所見や造影剤漏出がなければTAEは不要で、鎮痛・安静と入院観察でよい。

・過換気などの心因性反応をショックと取り違えない。

症例24 | 頭部外傷・抗凝固薬内服

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能なら呼吸: 見たまま安定。循環: BP 113/74、HR 78。意識: 来院時JCS 1〜3程度、指示には従える

傷病者役

同じ質問を繰り返す。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BP 113/74、HR 78、SpO2 98%、RR 18

診察所見

麻痺なし、瞳孔不同なし、短期記憶障害。

治療判断

抗凝固薬内服中のため、頭部CT再検を含む反復評価。EUで経過観察。

進行指示

同じ質問を繰り返す演技。頭部CTで少量外傷性SAHを提示し、観察判断を促す。

確認項目

☐ 同じ質問を繰り返す短期記憶障害を演じさせる

☐ 抗凝固薬内服と一時JCS20の病歴を二次評価で確認させる

☐ 一次緑から黄へアップし、救外へ移動する判断を確認する

☐ 頭部CTで少量の外傷性SAHを提示する

☐ 頭部CT再検を含む反復評価とEUでの経過観察の判断を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 113/74、HR 78、SpO2 98%、RR 18を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、頭部CTで外傷性SAH少量。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：高齢設定は人形または説明で代替し、学生には症状表現を中心に依頼。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 意識はJCS 1〜3で推移し、バイタル安定のままEUで経過観察となる。

遅れた場合: JCS20、頭痛・嘔吐の増強、HR 55・BP 170/90を提示し、CT再検で出血増大を示して脳神経外科コンサルトを促す。

傷病者役

同じ質問を繰り返す。

固定情報・備考

ムラージュ：前額部挫創

学習ポイント：・抗凝固薬内服例は軽微な頭部外傷でも遅発性の出血増大リスクが高い。

・同じ質問の反復（短期記憶障害）は見逃されやすい意識障害のサイン。

・少量のSAHでも、CT再検を含む反復評価のためEU入院が必要。

症例25 | 右肩脱臼

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

右肩を支えて痛がる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

右肩挙上不能、末梢循環保たれる。

治療判断

整復/固定

進行指示

右肩変形と強い疼痛を提示。整復・固定の見なし処置を確認。

確認項目

- ☐ 右肩の変形・挙上不能・強い疼痛を提示する
- ☐ 末梢循環・知覚が保たれていることを提示する
- ☐ X線で右肩脱臼を提示する
- ☐ 鎮痛と整復・固定の見なし処置、軽症ゾーンでの処置優先順位を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で右肩脱臼。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーンに処置待ち患者を増やし、処置優先順位を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 整復後に疼痛が軽減し、固定のうえ帰宅可能。

遅れた場合: 疼痛増強と上肢のしびれを提示し、整復前後の神経・循環評価を促す。

傷病者役

右肩を支えて痛がる。

固定情報・備考

ムラージュ：右肩変形設定

学習ポイント：・脱臼は整復前後で末梢循環・神経所見の確認が必須。

・軽症ゾーンにも処置を要する黄症例があり、処置の優先順位付けが必要。

症例26 | 前腕骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

腕を動かすと強く痛がる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

末梢循環・知覚正常。

治療判断

整復/シーネ

進行指示

前腕変形・強い疼痛を提示し、末梢循環・感覚確認とシーネ固定を促す。

確認項目

- ☐ 前腕の変形・腫脹と強い疼痛を提示する
- ☐ 末梢循環・知覚が正常であることを提示する
- ☐ X線で前腕骨折を提示する
- ☐ 整復・シーネ固定と固定後の再評価を確認する

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で前腕骨折。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車3で来院。処置待ちの黄症例を増やし、軽症ゾーンの優先順位を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 固定後に疼痛が軽減し、帰宅可能。

遅れた場合: 指のしびれ・冷感と腫脹増悪を提示し、コンパートメント症候群への注意を促す。

傷病者役

腕を動かすと強く痛がる。

固定情報・備考

ムラージュ：前腕変形・腫脹

学習ポイント：・骨折の整復・固定の前後で必ず末梢循環と神経所見を評価する。

・固定後の腫脹増悪によるコンパートメント症候群に注意する。

症例27 | 粉塵吸入後の咳嗽

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in. 歩行: 可能. 呼吸: RR 24、SpO2 93%RA、咳嗽あり. 循環: 脈拍は見たまま安定. 意識: 指示に従える

傷病者役

咳き込みながら会話可能。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：SpO2 93%RA、RR 24、他安定

診察所見

軽い喘鳴、呼吸苦軽度。

治療判断

酸素/吸入

進行指示

すす汚れ、咳嗽、SpO2 93%を提示。酸素/吸入と経過観察を促す。

確認項目

- ☐すす汚れと咳嗽を提示する
- ☐一次は緑、二次評価でSpO2 93%RAを確認し黄へアップできるか
- ☐酸素・吸入の指示が出るか
- ☐胸部X線異常なしを提示する
- ☐再評価のうえ帰宅判断ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、SpO2 93%RA、RR 24、他安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、胸部X線異常なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例20（喘息発作）と合わせて呼吸器症状の鑑別・優先順位を確認。

分岐・悪化条件

酸素・吸入で対応できた場合: SpO2が改善し咳嗽も軽減、経過観察後に帰宅可能。

酸素化低下を見逃した場合: SpO2がさらに低下し呼吸数増加・呼吸困難の訴えが増強する。

傷病者役

咳き込みながら会話可能。

固定情報・備考

ムラージュ：すす汚れ軽度

学習ポイント：粉塵曝露後は胸部X線が正常でも軽度低酸素をきたしうる。

歩行可能でもSpO2 93%は二次評価で黄へアップする根拠になる。

酸素・吸入への反応を再評価してから帰宅判断を行う。

症例28 | 低血糖

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能なら呼吸: 見たまま安定。循環: HR 100、冷汗あり。意識: 会話可能で指示に従える

傷病者役

ぼんやり、甘いものの摂取で改善。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：HR 100、他安定

診察所見

冷汗、神経局在なし。

治療判断

ブドウ糖投与

進行指示

冷汗・ふらつき・血糖48 mg/dLを提示。ブドウ糖投与後改善とする。

確認項目

☐ 冷汗・ふらつき・ぼんやりした様子を提示する

☐ 二次評価で血糖測定が行われるか

☐ 血糖48 mg/dLを提示する

☐ ブドウ糖投与の指示が出るか

☐ 投与後の症状改善を確認し帰宅判断ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、HR 100、他安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、血糖 48 mg/dL。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症に見える内因性疾患を混ぜ、血糖測定を促す。

分岐・悪化条件

血糖を測定しブドウ糖を投与できた場合: 症状は速やかに改善し帰宅可能。

血糖測定が行われない場合: 意識レベルが低下し（傾眠・応答不良）、内因性疾患の見逃しとなる。

傷病者役

ぼんやり、甘いものの摂取で改善。

固定情報・備考

ムラージュ：冷汗設定

学習ポイント：冷汗・ふらつきを見たら外傷以外に低血糖を鑑別し血糖を測定する。

避難中の食事摂取不良は災害時の低血糖の典型的な誘因。

ブドウ糖投与後は症状と血糖の再評価を行ってから帰宅を判断する。

症例29 | 不安・動悸

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

不安を繰り返し訴えるが会話可能。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

胸部聴診異常なし。

治療判断

安静/説明

進行指示

不安は強いが会話可能、心電図異常なしを提示。安心説明と過剰検査抑制を促す。

確認項目

☐ 動悸・不安の訴えを繰り返す

☐ バイタル安定・胸部聴診異常なしを提示する

☐ 心電図異常なしを提示する

☐ 傾聴と安心できる説明が行われるか

☐ 過剰検査を避けた帰宅判断ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、心電図異常なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーン混雑時に説明時間を要する患者を混ぜる。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

不安を繰り返し訴えるが会話可能。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：災害ストレスによる不安・動悸は循環不全を伴わず、バイタルと心電図で器質的疾患を除外できる。

混雑時こそ説明に時間を要する患者への対応方針をあらかじめ決めておく。

不要な検査を重ねないことが軽症ゾーンの資源温存につながる。

症例30 | 膝擦過傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

処置後すぐ歩ける。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

関節可動域良好。

治療判断

洗浄/被覆

進行指示

関節可動域良好、浅い擦過傷。洗浄・被覆後すぐ歩行可能とする。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、画像不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症創傷の大量処理・帰宅導線確認に使用。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

処置後すぐ歩ける。

固定情報・備考

ムラージュ：膝擦過傷

学習ポイント：浅い擦過傷は洗浄・被覆で対応でき、画像検査は不要。

関節可動域と創の深さを確認し、異常がなければ緑として帰宅導線へ。

軽症創傷を滞りなく処理することが軽症ゾーンの回転を保つ。

症例31 | 軽い腰痛

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

腰を押さえるが歩ける。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

下肢麻痺なし、膀胱直腸障害なし。

治療判断

鎮痛/帰宅

進行指示

下肢麻痺なし、膀胱直腸障害なしを提示。赤旗確認後に帰宅判断へ。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、検査不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例21（腰椎圧迫骨折）との重症度比較に使う。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

腰を押さえるが歩ける。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：腰痛では下肢麻痺・膀胱直腸障害などのレッドフラッグの有無を確認する。

歩行可能でこれらがなければ検査は不要で、鎮痛のうえ帰宅可能。

歩行不能・叩打痛の強い症例（症例21）との緊急度の差を意識する。

症例32 | 鼻出血

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

鼻を押さえて来院。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

顔面変形なし、止血確認。

治療判断

圧迫止血

進行指示

圧迫で止血可能、顔面変形なしを提示。止血確認と帰宅説明を促す。

確認項目

☐ 鼻を押さえて来院し、鼻出血少量・意識清明を提示する

☐ 正しい部位の圧迫止血が行われるか

☐ 顔面変形の有無を確認するか

☐ 止血確認と帰宅時の説明ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、追加検査不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーンで見た目に出血がある患者を混ぜる。

分岐・悪化条件

適切な圧迫が行われた場合: 止血が得られ帰宅可能。
圧迫が不十分・途中で中断された場合: 出血が持続し処置に時間を要する。

傷病者役

鼻を押さえて来院。

固定情報・備考	ムラージュ：鼻出血設定 学習ポイント：見た目の出血に惑わされず、バイタルと意識で緊急度を判断する。 前鼻部の圧迫で止血可能なことが多く、追加検査は不要。 顔面変形がないことを確認したうえで帰宅説明を行う。
---------	--

症例33 | 小児下腿骨折（閉鎖骨折）

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: RR 24、努力呼吸なし。循環: HR 120、足背動脈触知良好、ショック所見なし。意識: 指示に従える

傷病者役

学童人形を使用。倒れた場に下腿を挟まれた設定。動かすと強く痛がるが末梢循環・感覚は保たれる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：HR 120、BP 100/65、SpO2 99%RA、RR 24、BT 36.9

診察所見

下腿中央の変形・圧痛・腫脹、開放創なし、足背動脈触知良好、末梢神経障害なし。

治療判断

鎮静下に徒手整復＋シーネ固定、整形外科コンサル。EUもしくは一般病床入院で経過観察。

進行指示

末梢循環・神経所見の維持を確認。疼痛管理と鎮静下整備の準備を促す。

確認項目

☐ 足背動脈・感覚・足趾運動を評価するか

☐ 開放創の有無を確認するか

☐ 疼痛管理が早期に行われるか

☐ 鎮静下整備の準備とモニタリングができるか

☐ 固定前後で神経血管所見を再確認するか

☐ 整形外科コンサルと入院調整ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、HR 120、BP 100/65、SpO2 99%RA、RR 24、BT 36.9を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線で脛骨・腓骨骨折。コンパートメント症候群に注意。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（談当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車4で家族同伴来院。軽症ゾーンでの小児対応と鎮静下処置の準備を確認する。

分岐・悪化条件

末梢の神経・血流が正常で対応できた場合: 鎮静下の徒手整復＋シーネ固定で経過観察可能。

安静時痛の増強・他動的伸展時痛・腫脹緊満・感覚異常が出現した場合: コンパートメント症候群を疑い、コンパートメント圧測定と緊急筋膜切開が必要。

長時間挟まれていた場合: クラッシュ症候群として高K血症・ミオグロビン尿・AKIの監視と十分な輸液を要する。

傷病者役

学童人形を使用。倒れた場に下腿を挟まれた設定。動かすと強く痛がるが末梢循環・感覚は保たれる。

固定情報・備考

ムラージュ：下腿の腫脹・変形、皮下出血（開放創なし）

学習ポイント：圧挫肢ではコンパートメント症候群の6P（疼痛・蒼白・脈拍消失・感覚異常・運動麻痺・緊満）を随時評価する。

閉鎖骨折でも長時間圧迫があればクラッシュ症候群（再灌流による高K血症・横紋筋融解・AKI）を念頭に置く。

小児の手技的鎮静は安全管理とモニタリングが必須。

固定の前後で神経血管所見を繰り返し確認する。

症例34 | 左手掌切創

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

左手をガーゼで圧迫したまま来院。血が滲んでいることを心配し、傷口を見られると顔をそむける。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値

診察所見

左手掌母指球部に約3cmの切創。深さは皮下組織まで。手指屈伸可能。

治療判断

洗浄・縫合

進行指示

止血済み、腱・神経損傷なしを提示。洗浄・縫合の見なし処置を促す。

確認項目

- ☐ 止血済みのガーゼ圧迫の状態を提示する
- ☐ 異物・腱損傷・神経損傷の評価が行われるか
- ☐ 手指の自動屈伸と知覚を確認するか
- ☐ 洗浄・縫合の見なし処置ができるか
- ☐ 帰宅説明ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、異物なし。腱損傷・神経損傷なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車4で来院。ムラージュ対象として学生演技の視認性を高める。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

左手をガーゼで圧迫したまま来院。血が滲んでいることを心配し、傷口を見られると顔をそむける。

固定情報・備考

ムラージュ：あり

学習ポイント：手掌切創では創閉鎖の前に異物、腱・神経損傷の有無を評価する。

手指の自動屈伸と知覚が保たれていれば深部損傷の可能性は低い。

皮下組織までの約3cmの切創は洗浄・縫合で帰宅可能。

症例35 | 左外傷性血気胸・皮下気腫

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「JCS10、GCS 13（E3V4M6）、HR 130、BP 85/45、SpO2 90%（15Lリザーバー）」を提示する。

一次トリアージ所見

JCS10、左前胸部圧痛、喀血、左呼吸音減弱、頸静脈怒張

傷病者役

目を閉じ、呼びかけで開眼。左前胸部を押さえ、時々嘔き込み口元を押さえる。挿管後は目を閉じる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：JCS10、GCS 13（E3V4M6）、HR 130、BP 85/45、SpO2 90%（15Lリザーバー）

診察所見

左前胸部圧痛、左呼吸音聴取せず、皮下気腫あり。

治療判断

左胸腔ドレナージ、気管挿管・人工呼吸管理。手術は要しないためEU入院。

進行指示

胸腔ドレナージ後も酸素化不十分なら挿管・人工呼吸器管理を提示。ICU室床確認を促す。

確認項目

☐ 頸静脈怒張・左呼吸音消失・ショックを提示する

☐ 画像を待たずに胸腔減圧・胸腔ドレーンが行われるか

☐ 陽圧換気の前に胸腔が減圧されているか

☐ ドレナージ後も酸素化不十分なら挿管・人工呼吸管理へ移行できるか

☐ 人工呼吸管理を継続できる病床（EU）の確保と本部連携ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、JCS10、GCS 13（E3V4M6）、HR 130、BP 85/45、SpO2 90%（15Lリザーバー）を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、胸部X線/CT: 左外傷性血気胸、皮下気腫。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（談当時）

コントローラー

追加イベント：ICU候補が同時に増え、本部・ICU連携を確認。

分岐・悪化条件

直ちに胸腔ドレーンを留置できた場合: 換気・循環が改善し安定化する。

画像を待ってドレーンが遅れた場合: 緊張性生理により閉塞性ショック・心停止に至る。

気胸未処置のまま陽圧換気を行った場合: 緊張性気胸が増悪する。

傷病者役

目を閉じ、呼びかけで開眼。左前胸部を押さえ、時々嘔き込み口元を押さえる。挿管後は目を閉じる。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：緊張性気胸は臨床診断で即時減圧し、画像を待たない。

陽圧換気の前に胸腔ドレーンを留置する。

皮下気腫は気道・肺損傷を、頸静脈怒張は閉塞性ショックを示唆する。

安定化後は人工呼吸管理を継続できる病床を早期に確保する。

症例36 | 重症心身障害児の低酸素（酸素供給途絶）

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: 用手換気下、SpO2 82%、努力呼吸あり。循環: HR 140、BPは正常範囲。意識: 反応はあるが重症心身障害児設定で評価困難

傷病者役

重症心身障害児の人形＋気管切開・人工呼吸器モデルを使用。家族役が「地震で停電し酸素濃縮器が止まった」と説明し、用手換気しながら搬入。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：SpO2 82%（用手換気下）、HR 140、BP 正常範囲、RR 補助換気、BT 37.0

診察所見

気管切開部に問題なし、両肺で換気音聴取、痰貯留あり、酸素化不良。

治療判断

酸素供給の確保・吸引・換気の安定化。小児重症例のためICU管理とし、小児科と調整。

進行指示

停電時のHOT/人工呼吸器の挙動（内蔵バッテリーは作動するが酸素供給は途絶）を解説。酸素源確保と入院調整を促す。

確認項目

- ☐ 停電で酸素濃縮器が停止した経緯を家族から聴取できるか
- ☐ まず換気ができているかを確認するか
- ☐ DOPE（逸脱・閉塞・気胸・機器不良）を系統的に評価するか
- ☐ 酸素源（配管・ポンプ）の確保と気管吸引ができるか
- ☐ 改善なければ気管切開チューブ交換へエスカレーションできるか
- ☐ 小児重症例としてICU管理を前提に小児科と調整できるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、SpO2 82%（用手換気下）、HR 140、BP 正常範囲、RR 補助換気、BT 37.0を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、血液ガスで低酸素血症。胸部X線で無気肺/痰貯留を評価。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車5で家族が用手換気しながら来院。母親は症例37として同時受付となる。

分岐・悪化条件

酸素再供給＋気管吸引＋換気の確立ができた場合: SpO2が回復し安定、ICU管理のうえ小児科と調整。

気切チューブの痰閉塞・位置異常を放置した場合: 低酸素が遷延し徐脈からCPAIに至る。

用手換気で胸郭挙上不良・抵抗大の場合: DOPEを順に確認し、改善なければ気切チューブを交換する。

傷病者役

重症心身障害児の人形＋気管切開・人工呼吸器モデルを使用。家族役が「地震で停電し酸素濃縮器が止まった」と説明し、用手換気しながら搬入。

固定情報・備考

ムラージュ：気管切開部、人工呼吸回路（演者は人形ノシミュレータ併用可）

学習ポイント：HOTの酸素濃縮器は電力依存で、停電は酸素供給の停止に直結する。

在宅人工呼吸器は内蔵バッテリーで換気を維持できても酸素化は低下しうる。

気管切開・人工呼吸器トラブルはDOPEで系統的に評価し、吸引→チューブ交換へエスカレーションする。

小児重症例としてICU管理を維持し、小児科と早期に連携する。

症例37 | 前額部擦過傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

乗用車5（症例36の母親）。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

前額部の傷を気にして触ろうとする。痛みは軽度。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値。頭痛・嘔気・意識障害なし

診察所見

前額部5×3cm大の擦過傷。表皮剥離、軽度滲出。

治療判断

洗浄、被覆、ステリテープ等

進行指示

症例36の母親として来院。頭痛・嘔気・意識障害なし。洗浄・被覆・ステリテープで帰宅可能とする。症例36の対応状況を母親へ説明する場面も設定できる。

確認項目

特になし

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値。頭痛・嘔気・意識障害なしを確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、異常なしを提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車5で症例36に付き添って来院。重症児対応と並行して家族の軽症外傷をどう処理するかを問う。

分岐・悪化条件

記載なし

傷病者役

前額部の傷を気にして触ろうとする。痛みは軽度。

固定情報・備考

ムラージュ：あり

学習ポイント：前額部擦過傷は洗浄・被覆・ステリテープで対応でき縫合は不要。

頭痛・嘔気・意識障害がないことを確認して頭部外傷を除外する。

付き添い家族自身の軽症外傷への対応と、児の状況説明を並行して行う。

症例38 | 脳梗塞疑い

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 不安定で自力歩行困難。呼吸: 見たまま安定。循環: 脈拍は見たまま安定。意識: 指示に従えるが呂律不良あり

傷病者役

右足が出しにくく、少し呂律が回らない。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

パレー陽性、右上下肢軽度脱力。

治療判断

脳卒中対応（画像評価・適応判断）。EU入院で神経所見を監視。

進行指示

乗用車4。スーパーで倒れた後の体動困難として登場させ、右上下肢脱力と構音障害を提示。二次トリアージで救外移動を判断させる。

確認項目

- ☐ 右上下肢の脱力と呂律不良を提示する
- ☐ 二次トリアージで神経所見（パレー徴候・構音）を取り直すか
- ☐ 発症時刻／最終未発症時刻を確認するか
- ☐ 軽症ゾーンから救外へ移動し脳卒中コードを起動できるか
- ☐ 画像評価と再灌流療法の適応判断ができるか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、MRIで脳梗塞。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（談当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車4の同乗者として来院。軽症ゾーン混雑時に紛れ込ませ、再評価とゾーン間連絡を確認。

分岐・悪化条件

二次トリアージで神経所見を評価し救外へ振り分けた場合: 適応に応じてrt-PA・血栓回収療法へ進める。

「歩けるから緑」と判断し軽症ゾーンで待機させた場合: 治療可能時間を逸失し梗塞が不可逆的に拡大する。

発症時刻が不明のまま経過した場合: 再灌流療法の適応判断が遅れる。

傷病者役

右足が出しにくく、少し呂律が回らない。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：脳梗塞は歩行可能でも緊急度が高く、片麻痺・構音障害はトリアージアップの根拠となる。

rt-PA（発症4.5時間以内）や血栓回収療法の適応は発症時刻に依存するため、最終未発症時刻の確認が最重要。

二次トリアージで神経所見を取り直す再評価が鍵となる。

災害時でも内因性疾患は発生し、限られた画像・人的資源の中で適応を判断する。

症例39 | 急性腹症疑い

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸: 見たまま安定。循環: HR 105、脱水傾向あり。意識: 指示に従える

傷病者役

腹部を押さえてうずくまる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：HR 105、他安定

診察所見

右下腹部圧痛、反跳痛なし。

治療判断

輸液・鎮痛・画像評価。外科と協議のうえEU入院で経過観察。

進行指示

腹痛・嘔吐・脱水傾向を提示し、画像評価と救外移動の判断を促す。

確認項目

- ☐ 二次トリアージでHR105・嘔吐反復・脱水を確認したか
- ☐ 「歩けるから緑」で固定せず再評価したか
- ☐ 輸液・鎮痛を開始したか
- ☐ 画像（CT）の必要性と優先順位を判断したか
- ☐ 外科と協議しEU入院を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、HR 105、他安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、採血で脱水、CTで虫垂炎/腸炎鑑別。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：軽症ゾーン混雑時に非外傷疾患を混ぜ、見落としを防ぐ訓練にする。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 二次評価でトリアージアップし、輸液・鎮痛と画像評価のうえEU入院で経過観察に入れる。

遅れた場合: 軽症ゾーンで待機が続き、脱水と腹痛が進行して反跳痛の出現・頻脈増悪など腹膜炎徴候が顕在化する。

傷病者役

腹部を押さえてうずくまる。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：歩行可能な腹痛でも、頻脈（HR105）・反復する嘔吐・脱水は緊急度上昇のサイン。

反跳痛がなくても虫垂炎・腸炎は経時的に進行するため、一度のトリアージで固定せず再評価する。

脱水補正・鎮痛と外科適応の判断、災害時の画像・検査資源の配分を意識する。

症例40 | 肝損傷

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「HR 125、BP 78/50、SpO2 94%RA、RR 30」を提示する。

一次トリアージ所見

右側腹部痛、低血圧、頻脈、右側腹部圧痛・筋性防御

傷病者役

右上腹部を強く押さえ、前傾姿勢でぐったり。体動や触診で激痛。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：HR 125、BP 78/50、SpO2 94%RA、RR 30

診察所見

右側腹部に圧痛・筋性防御、顔面やや蒼白。TAE後は腹部膨満が進行。

治療判断

輸液・輸血、肝損傷に対しTAE（AG）で止血。TAE後に再出血して循環が不安定となり、緊急開腹によるダメージコントロール手術（ガーゼパッキング）を施行。腹部術後のためICU管理。

進行指示

FAST陽性を提示し、造影CT/止血治療の優先順位判断を促す。TAE後にBP 76/48・HR 135・Hb 6.8・腹部膨満を提示し、再出血に対する緊急開腹（ダメージコントロール手術）と術後ICU入室の調整を判断させる。カテ室・手術室・ICUの同時調整が必要な症例として扱う。

確認項目

☐ FASTを実施し陽性所見をチームで共有したか

☐ 輸液・輸血への反応（responder／transient／non-responder）を分類したか

☐ 血行動態からCT室へ運べるかを判断したか

☐ AG室へTAEを依頼したか

☐ TAE後の血圧低下・Hb低下・腹部膨満から再出血を捉えたか

☐ 緊急開腹（ダメージコントロール手術）と術後ICU入室を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、HR 125、BP 78/50、SpO2 94%RA、RR 30を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、FAST: モリソン窩陽性。造影CT: 肝損傷、腹腔内出血。TAE後: Hb 6.8へ低下、FASTで腹腔内液体の増加。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：TAE終了後、ERでの処置中に血圧低下と腹部膨満を付与し、再出血に対する緊急開腹（ダメージコントロール）と術後ICU入室の調整を判断させる。以降は演技不要で、モニター値・検査値の提示で進行させる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: TAEで一旦止血し、再出血を早期に捉えて緊急開腹→ICU入室まで滞りなく進む。

遅れた場合: transient responderを安定と誤認してCT室や待機で時間を浪費し、BP・Hbがさらに低下、腹部膨満が進行して開腹止血までの時間が延びる。

傷病者役

右上腹部を強く押さえ、前傾姿勢でぐったり。体動や触診で激痛。

固定情報・備考	ムラージュ：不要 学習ポイント：鈍的腹部外傷＋FAST陽性（モリソン窩）＋ショックでは、輸液・輸血への反応性で方針が分かれる。 安定化すれば造影CT→TAEなどの非手術的管理、反応不良なら緊急開腹止血を躊躇しない。 TAE後も再出血しうするため、血圧・Hb・腹部所見の反復評価とダメージコントロール手術への切り替え判断が要る。
---------	---

症例41 | 大腿骨骨折＋脂肪塞栓症候群

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能のため黄。呼吸: 初期は見たまま、その後SpO2 80%RAを付与。循環: 初期HR 100、BP 120/70。意識: 初期は指示に従えるが、二次で突然ぐったりし意識低下

傷病者役

一次～二次までは右大腿を痛がる。二次からJCS20まで悪化し、呼吸を荒くする。酸素後も意識は悪いまま。挿管以降は反応を返さず、コントローラーの数値提示で進行する（演技不要）。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：初期: BP 120/70、HR 100、SpO2 96%RA

診察所見

右大腿部の腫脹と圧痛、大腿中央部変形、患肢短縮と外旋位。

治療判断

骨折固定、酸素投与のうえ気管挿管・人工呼吸管理（肺保護換気・高PEEP）。P/F比 55と極端な酸素化不良でECMO導入の可能性ありとしてICU入室。骨接合術は全身状態安定後に予定。

進行指示

初期は大腿骨骨折として提示。途中でSpO2 80%、意識低下、点状出血を付与し救外移動を促す。挿管・人工呼吸後もPaO2 55mmHg（FiO2 1.0）＝P/F比 55と提示し、ECMO導入の可能性を含むICU入室と臨床工学技士の招集、骨接合術の延期を判断させる。

確認項目

☐ 二次トリアージ中のSpO2低下・意識変容を捉えたか

☐ 点状出血を含む三徴を確認し赤ヘトリアージアップしたか

☐ 大腿骨骨折を早期に固定したか

☐ 気管挿管・肺保護換気（高PEEP）へ移行したか

☐ P/F比55の高度低酸素を共有し、ECMO準備をICU・臨床工学技士へ依頼したか

☐ 骨接合術の延期とICU入室を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、初期: BP 120/70、HR 100、SpO2 96%RAを確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、X線: 大腿骨骨幹部骨折。胸部X線・CT: 両肺びまん性のすりガラス～snow storm様陰影。血液ガス: PaO2 55mmHg（FiO2 1.0）でP/F比 55。血小板低下、Hb低下。MRI: 脂肪塞栓症候群。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車6で来院。同乗の症例45（胸部症状）と同時に受付となる。軽症ゾーン混雑時に発生させ、再評価能力を確認する。挿管・人工呼吸後も酸素化が改善しない設定とし、ECMO導入の可能性ありとしてICU・臨床工学技士へ準備を依頼させる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 急変を早期に捉えて酸素投与・挿管へ移行し、ICU入室とECMO準備の手配を並行して進められる。

遅れた場合: 骨折のみと判断して監視が弱く、SpO2低下と意識障害が進行してARDS様の呼吸不全となり、挿管・ECMO調整が後手に回る。

傷病者役

一次～二次までは右大腿を痛がる。二次からJCS20まで悪化し、呼吸を荒くする。酸素後も意識は悪いまま。挿管以降は反応を返さず、コントローラーの数値提示で進行する（演技不要）。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：長管骨骨折後12～72時間に、呼吸障害・意識障害・点状出血の三徴で脂肪塞栓症候群を発症しうる。

早期の骨折固定が予防に有効で、経過観察中の急変（SpO2低下）を捉える再評価が重要。

人工呼吸管理のみならEUだが、P/F比が極端に低くECMO候補となる例は絶対的ICU適応であり、回路・臨床工学技士の資源調整が要る。

症例42 | 軽い腹痛

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

普通に会話可能。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

腹部軟、反跳痛なし。

治療判断

経過観察

進行指示

腹部軟、反跳痛なし、バイタル安定を提示。経過観察後に帰宅可能とする。

確認項目

☐ 腹部所見（腹部軟、反跳痛なし）を確認したか

☐ バイタル安定を確認したか

☐ 過剰な検査を避けて経過観察としたか

☐ 増悪時の再受診を説明し帰宅導線に乗せたか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、必要時採血異常なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例39（急性腹症疑い）との重症度比較に使う。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 経過観察のみで帰宅でき、軽症ゾーンの負荷を増やさない。

遅れた場合: 不要な検査で軽症ゾーンが滞留し、症例39のような再評価を要する腹痛への対応が遅れる。

傷病者役

普通に会話可能。

固定情報・備考	ムラージュ：記載なし 学習ポイント：軽症の腹痛では腹部所見とバイタルで重症サインの有無を確認する。 重症所見がなければ経過観察・帰宅とし、症例39（急性腹症疑い）との重症度の差を意識する。
---------	---

症例43 | 眼の異物感

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

目をこする、洗眼で改善。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

結膜充血軽度。

治療判断

洗眼

進行指示

視力低下なし、角膜損傷なしを提示。洗眼で改善とする。

確認項目

☐ 視力低下の有無を確認したか

☐ 角膜損傷・異物残存を確認したか

☐ 洗眼を実施したか

☐ 帰宅可能と判断し帰宅導線を案内したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、角膜損傷なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：粉塵曝露患者を複数混ぜ、軽症ゾーン処置を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 洗眼で症状が改善し帰宅でき、粉塵曝露患者の処置を短時間で回せる。

遅れた場合: 異物感が持続して軽症ゾーンでの待機が延び、同時来院する粉塵曝露患者の処置が滞る。

傷病者役

目をこする、洗眼で改善。

固定情報・備考

ムラージュ：眼周囲すす汚れ

学習ポイント：粉塵曝露による眼の異物感では、視力と角膜損傷の有無を確認する。

視力低下や角膜損傷がなければ洗眼で改善し、帰宅可能と判断できる。

コントローラ配布資料（症例別）をもとに生成 | 症例43 | 眼の異物感

症例44 | 肩こり・頭重感

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

Walk-in。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

疲労感を訴える。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値で安定

診察所見

項部硬直なし、麻痺なし。

治療判断

休息/内服

進行指示

項部硬直なし、麻痺なしを提示。休息・内服で帰宅可能とする。

確認項目

- ☐ 項部硬直・麻痺など神経所見を確認したか
- ☐ バイタル安定を確認したか
- ☐ 過剰な検査（頭部CT）を避けたか
- ☐ 休息・内服で帰宅と説明したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値で安定を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、検査不要。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：神経症状のない頭部症状として、症例3（急性硬膜外血腫）・症例24（頭部外傷・抗凝固薬内服）との重症度差を確認する。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 短時間で帰宅と判断でき、軽症ゾーンの回転を維持できる。

遅れた場合: 不要な頭部CTで検査待ちが増え、症例3・症例24など真に画像を要する頭部外傷の検査が後回しになる。

傷病者役

疲労感を訴える。

固定情報・備考

ムラージュ：記載なし

学習ポイント：神経所見がなくバイタルが安定していれば、疲労に伴う肩こり・頭重感は休息・内服で帰宅可能。

頭部外傷症例（症例3、症例24）との重症度差を意識し、限られた画像・検査資源を配分する。

症例45 | 完全房室ブロック合併下壁STEMI

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

乗用車で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

歩行: 歩行不能。呼吸: RR 20、SpO2 94%RA。循環: 脈拍数30、末梢冷汗あり。意識: 清明で指示に従える

傷病者役

ぐったりし歩行困難。心高部圧迫感と嘔気、冷汗。経皮ペーシング時は痛みで反応。カテ室へ出候した時点で演技は終了（ER内では心停止させない）。以降は人形に交代する。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル: BP 100/50、HR 30、SpO2 94%RA、RR 20

診察所見

著明な徐脈、冷汗、胸部圧迫感、ふらつき、めまい、心高部圧迫感と嘔気。

治療判断

アトロピン、経皮ペーシング。カテ室搬送後にVFから心停止となり、CPR・除細動を実施。カテ室でECPR（PCPS導入）＋緊急PCIを行い、デバイス装着のためICU管理。

進行指示

乗用車6。救助作業中の発症として登場させる。完全房室ブロック＋下壁STEMIを提示し、アトロピン・経皮ペーシングを促す。ER内では心停止させず、カテ室搬送の判断を促す。カテ室へ出候した時点で学生の演技を終了し人形に交代。カテ室でVFを提示して心停止とし、CPR・除細動、ECPR（PCPS導入）＋緊急PCI、術後ICU入室までの調整を判断させる。カテ室は当日稼働可能とする。

確認項目

- ☐ HR30の徐脈性ショックを認識しモニタ・除細動器を準備したか
- ☐ アトロピン、無効時の経皮ペーシングを実施したか
- ☐ 下壁STEMI（右室梗塞）を疑い硝酸薬を避け輸液で前負荷を維持したか
- ☐ カテ室へ早期連絡し搬送を判断したか
- ☐ カテ室でのVF／心停止にCPR・除細動で対応したか
- ☐ ECPR（PCPS）＋緊急PCIのため循環器・臨床工学技士を招集し、ICU入室を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 100/50、HR 30、SpO2 94%RA、RR 20を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、心電図: 完全房室ブロック、下壁STEMI。カテ室搬送後の急変時はVF。冠動脈造影で右冠動脈近位部の完全閉塞。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：乗用車6で症例41と同時に来院。外傷重症例と内因性重症例が重なり、手術室・カテ室・ICUの調整が同時に必要となる。進行の詳細はコントローラー指示を参照。

分岐・悪化条件

対応できた場合: ERで徐脈性ショックを安定化→カテ室搬送→VFにCPR・除細動→ECPR（PCPS）＋緊急PCI→ICU入室まで自院で完結する。

遅れた場合: カテ室連絡が遅れて待機が長引き、徐脈と低血圧が悪化して梗塞が拡大、蘇生からPCIまでの時間が延びる。

傷病者役

ぐったりし歩行困難。心高部圧迫感と嘔気、冷汗。経皮ペーシング時は痛みで反応。カテ室へ出候した時点で演技は終了（ER内では心停止させない）。以降は人形に交代する。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：下壁STEMIは房室ブロック・徐脈を合併しやすく、右室梗塞を合併すると前負荷依存となり硝酸薬で著明な血圧低下をきたす。

徐脈にはアトロピン→無効ならペーシング、根本治療は再灌流（PCI）でdoor-to-balloonを意識する。

カテ室内心停止ではECPR（PCPS）の適応判断とチーム招集が鍵となる。

災害ストレスで内因性のACSが発生しうる。

症例46 | 右緊張性気胸・フレイルチェスト

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「JCS10、GCS 13（E3V4M6）、BP 62/35、HR 130、SpO2 88%（15L）」を提示する。

一次トリアージ所見

右胸部痛、高度呼吸困難、右呼吸音減弱、奇異呼吸、頸静脈怒張、顔面蒼白

傷病者役

右胸部を痛がり、ぐったりして会話はほとんどできない。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：JCS10、GCS 13（E3V4M6）、BP 62/35、HR 130、SpO2 88%（15L）

診察所見

皮下気腫著明、右呼吸音減弱、フレイルチェストあり。ドレーン・挿管後にSpO2改善。

治療判断

直ちに胸腔減圧、胸腔ドレーン、必要時に気管挿管・人工呼吸管理。循環・呼吸が安定後にCT。手術は要しないためEU入院。

進行指示

右呼吸音減弱、頸静脈怒張、ショックを提示。緊張性気胸として迅速処置を促す。

確認項目

- ☐ 頸静脈怒張・右呼吸音減弱・ショックから緊張性気胸を臨床診断したか
- ☐ CTを待たずに胸腔減圧→胸腔ドレーンを行ったか
- ☐ 減圧前の陽圧換気を避けたか
- ☐ 循環・呼吸が安定してからCTを実施したか
- ☐ フレイルチェストに対し挿管・陽圧換気と鎮痛を行ったか
- ☐ 人工呼吸管理を継続する入院先（EU）を本部と調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、JCS10、GCS 13（E3V4M6）、BP 62/35、HR 130、SpO2 88%（15L）を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、胸腔減圧・胸腔ドレーンで安定化後のCT。右多発肋骨骨折、気胸。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：症例47（クラッシュ症候群）と相前後して到着。重症呼吸不全と透析候補が重なり、本部での入院先調整を促す。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 即時減圧で閉塞性ショックが改善し、BP・SpO2が回復して安定後のCT・人工呼吸管理へ進める。

遅れた場合: 画像待ちで減圧が遅れ、血圧・SpO2がさらに低下して心停止に至る。減圧前に陽圧換気を行うと緊張性気胸が増悪する。

傷病者役

右胸部を痛がり、ぐったりして会話はほとんどできない。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：頸静脈怒張＋呼吸音減弱＋ショックは緊張性気胸で、画像を待たず臨床診断で即時減圧する。

奇異呼吸を伴うフレイルチェストは肺挫傷を合併し、挿管・陽圧換気と鎮痛が有効。

陽圧換気的前提として胸腔減圧が必須である。

手術を要さず循環が安定すれば、人工呼吸管理はEUで継続する。

症例47 | クラッシュ症候群

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「BP 110/68、HR 88、SpO2 97%RA、RR 20。」を提示する。

一次トリアージ所見

下腿腫脹、水疱、知覚低下、褐色尿

傷病者役

下腿のしびれ、動かせない。治療遅延でCPAへ。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BP 110/68、HR 88、SpO2 97%RA、RR 20

診察所見

右下腿腫脹、知覚麻痺、足趾運動低下。

治療判断

大量輸液、高カリウム補正、CRRT（血液浄化）導入。デバイス装着のためICU管理。

進行指示

下腿腫脹、褐色尿、高Kを提示。大量輸液・高K補正に加え、CRRT導入とICU入室、臨床工学士の招集など自院内の調整を判断させる。

確認項目

- ☐ 心電図モニタを装着し高K血症の変化を監視したか
- ☐ 早期から大量輸液を開始したか
- ☐ 高K血症にカルシウム・GI療法を行ったか
- ☐ 褐色尿・CK高値から色素性腎症を想起し尿量を確保したか
- ☐ コンバートメント症候群を評価したか
- ☐ CRRT導入とICU入室、臨床工学士の招集を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 110/68、HR 88、SpO2 97%RA、RR 20を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、血液ガスでK高値、CK高値、褐色尿。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（談当時）

コントローラー

追加イベント：救急車⑧で搬入し、重症患者の優先順位を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 輸液と高K補正で致死性不整脈を回避し、尿量を保ちながらCRRT導入とICU管理へ移行できる。

遅れた場合: 高K血症が進行しテント状T波→QRS開大→sine waveからVF／心停止に至り、輸液不足で色素性腎症によるAKIが進行する。

傷病者役

下腿のしびれ、動かせない。治療遅延でCPAへ。

固定情報・備考

ムラージュ：右下腿腫脹・水疱

学習ポイント：クラッシュ症候群は圧挫解除の前後にreperfusion injuryで急変し、心電図モニタと大量輸液を先行させる。

高K血症の心電図変化（テント状T波→QRS開大→sine wave）を認識し直ちに治療する。

色素性腎症予防のための輸液・尿量管理と、CRRT（透析）の適応判断が重要。

区画（コンバートメント）症候群の評価を忘れない。

症例48 | シートベルト外傷（腹部）

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「BP 110/70、HR 118、SpO2 98%RA、RR 22、BT 36.8。」を提示する。

一次トリアージ所見

歩行可だが腹痛で前屈み、シートベルト痕、頻脈。血圧は保たれる

傷病者役

中学生役は学生が演じる（学生演技）。腹部を押さえて痛がり、バイタルは保たれるが腹痛が増強していく。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：BP 110/70、HR 118、SpO2 98%RA、RR 22、BT 36.8

診察所見

下腹部～臍部にシートベルトサイン、腹部圧痛、上肢・顔面に打撲痕。

治療判断

救外で反復評価。腹部所見増悪時は外科コンサルのうえEU入院。

進行指示

腹痛増強・バイタル変化を段階的に提示し、経過観察→入院の判断を促す。

確認項目

- ☐ 来院時は緑として受け入れ、救外ゾーンで反復評価したか
- ☐ シートベルトサインを深部臓器損傷のレッドフラッグとして共有したか
- ☐ FAST・造影CT・採血を実施し経時フォローしたか
- ☐ 頻脈先行の代償性ショックを認識したか
- ☐ 腰背部痛・下肢神経症状からChance骨折を評価したか
- ☐ 所見増悪時に外科コンサルとEU入院を調整したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、BP 110/70、HR 118、SpO2 98%RA、RR 22、BT 36.8を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、FASTで明らかな腹腔内液貯留なし。造影CTで腸間膜・消化管損傷の有無を評価。採血で経時フォロー。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：時間とともに腹痛が増強（遅発性腸管・腸間膜損傷の懸念）。増悪時は入院・外科コンサル。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 反復評価で増悪を早期に捉え、外科コンサルのうえEU入院で経過観察できる。

遅れた場合: 腹痛増悪・腹膜刺激徴候・発熱や、FAST陽性転化・Hb低下・血圧低下が顕在化し、開腹手術が必要となる。

傷病者役

中学生役は学生が演じる（学生演技）。腹部を押さえて痛がり、バイタルは保たれるが腹痛が増強していく。

固定情報・備考

ムラージュ：腹部の帯状皮下出血（シートベルトサイン）、顔面・上肢打撲痕

学習ポイント：シートベルトサインは腸管・腸間膜損傷やChance骨折のレッドフラッグで、外表が軽くても油断しない。

中空臓器損傷はFASTや初回CTで見逃されやすく、反復した腹部診察と再評価が重要。

頻脈先行・血圧維持の代償性ショックを認識し、非代償化を早期に察知する。

症例49 | 頸椎捻挫

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

徒歩で到着。一次トリアージ所見を順に提示する。

一次トリアージ所見

徒歩来院。歩行: 可能。呼吸・脈拍・意識: すべて見たまま安定、指示に従える

傷病者役

後頸部から右肩にかけて痛いと訴える。激痛ではない。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：実測値

診察所見

後頸部～僧帽筋の疼痛。診察所見は異常なし。

治療判断

鎮痛、経過観察

進行指示

激痛ではなく、神経脱落なし。頸椎レントゲン異常なしを提示し経過観察へ。

確認項目

- ☐ 神経脱落症状の有無を確認したか
- ☐ 頸椎レントゲンの必要性を判断したか
- ☐ 鎮痛と経過観察の説明を行ったか
- ☐ 終盤の患者情報入力と帰宅導線を確認したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、実測値を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、頸椎レントゲンを行っても異常なし。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：徒歩来院の最終波。終盤の情報入力遅延と帰宅導線を確認。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 鎮痛・経過観察で帰宅となり、終盤の情報入力と帰宅導線が滞らない。

遅れた場合: 記録・情報入力が滞留し、帰宅手続きが遅れて軽症ゾーンの撤収に影響する。

傷病者役

後頸部から右肩にかけて痛いと訴える。激痛ではない。

固定情報・備考

ムラージュ：不要

学習ポイント：明らかな強打がなく神経脱落症状もない後頸部痛は、頸椎捻挫として鎮痛・経過観察とする。

画像で異常がなければ帰宅可能と判断し、終盤の記録・帰宅導線を滞らせない。

症例50 | 右下腿開放骨折

本体症例とリンクした、時系列の進行・提示資料

01 到着・一次評価

0-3分

コントローラー

救急車で到着。救急隊情報として「HR 110、BP 145/88、SpO2 95%RA、RR 20」を提示する。

一次トリアージ所見

右下腿約10cm開放創、骨露出、出血持続、下腿変形

傷病者役

右下腿を見ないようにし、創部出血を心配する。わずかな振動でも激痛。手術時期を不安がる。

02 初療から治療へ

3-12分

コントローラー

初回バイタル：HR 110、BP 145/88、SpO2 95%RA、RR 20

診察所見

右下腿に開放創、出血あり圧迫止血中、歩行不可。

治療判断

止血・固定、緊急手術（洗浄・デブリドマン＋骨折固定）。術後はEUもしくは一般病床入院。

進行指示

右下腿開放創・骨露出・出血を提示。洗浄・抗菌薬・固定のうえ、症例40・症例45など他の緊急症例との手術室優先順位調整を促す。

確認項目

- ☐ 圧迫止血を継続し出血をコントロールしたか
- ☐ 創部洗浄と抗菌薬投与を早期に行ったか
- ☐ 下腿の固定と疼痛管理を行ったか
- ☐ 末梢循環・神経所見を評価したか
- ☐ 手術室の空き状況を確認し、他の緊急手術（症例40・45等）との優先順位を調整したか
- ☐ 術後の入院先（EUまたは一般病床）を確保したか

検査・モニター提示

モニター

プレイヤーがモニター装着を依頼した時点で、「モニター画面のQRコード」を提示し、HR 110、BP 145/88、SpO2 95%RA、RR 20を確認させる。

検査・画像

プレイヤーが検査または画像撮影を決定した時点で、「検査・画像のQRコード」を提示する。確認後に、レントゲン: 右下腿開放骨折。を提示する。

03 急変・追加設定

12-20分（該当時）

コントローラー

追加イベント：手術室・カテーテル治療の優先順位調整が必要となる。

分岐・悪化条件

対応できた場合: 洗浄・抗菌薬・固定のうえ手術順位を調整し、緊急手術後にEUまたは一般病床へ入院できる。

遅れた場合: 洗浄・抗菌薬が遅れて創部汚染が進み、手術待機が長引いて出血と疼痛の管理が困難になる。

傷病者役

右下腿を見ないようにし、創部出血を心配する。わずかな振動でも激痛。手術時期を不安がる。

固定情報・備考

ムラージュ：あり

学習ポイント：開放骨折は早期の洗浄・デブリドマンと抗菌薬投与、確実な固定が基本。

出血は圧迫止血で管理し、末梢循環・神経所見を評価する。

手術室逼迫時は自院内での手術順位調整と術後入院先の確保が必要。